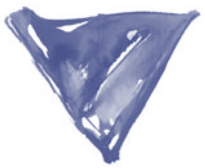
A mis pacientes,

por quienes me esfuerzo

para hacer mi trabajo

cada vez mejor.

Dr. Héctor Valdés



HECTOR VALDES

Manual Instructivo de Cirugía Estética

Unas palabras...

Tanto se ha escrito, tanto se ha dicho sobre la belleza, sin embargo, definirla es imposible. Quizás porque ella está en el ojo de quien la aprecia y no en el objeto en sí. Pueden dar testimonio de ello poetas, pintores, músicos y seguidores del arte de las más diversas culturas quienes han demostrado, lo que podríamos llamar, la subjetividad de lo bello.

Son los propios artistas los que con el pasar de los años han evidenciado que la belleza radica, precisamente, en la variación de ésta. Así pues el arte de la mano del tiempo se ha convertido en mudo testigo de las variaciones de la estética, dando cuenta de su relativismo.

Vestigios arqueológicos demuestran el valor que se le daba antiguamente en la imágen femenina a un busto y vientre prominentes. Con la llegada del cristianismo los modelos femeninos pierden ese rol sexual y durante siglos, las mujeres son plasmadas en la pintura como figuras virginales, delgadas y de busto pequeño, situación que cambia radicalmente durante el Renacimiento. Es en esta época, donde la mujer presenta una imagen pletórica de alegría y vivencias con un cuerpo exuberante que transmite femineidad.

Hoy en día, el concepto de belleza varía del anterior. Generalizando, podríamos decir que en occidente el prototipo de lo hermoso está ligado a un cuerpo delgado, desprovisto de grasa, con una mezcla de lo atrevido y lo atlético. En suma, la sensualidad y la sexualidad se imponen.

Si bien esto sucede en occidente, el concepto de belleza femenina cambia según las culturas, la región, los países e incluso, dentro de una misma nación.

Pero siguiendo con nuestro razonamiento, si bien predomina cierto ideal estético, podríamos afirmar que afortunadamente la belleza se manifiesta en el ser humano con una infinidad de rostros. Existen rasgos y detalles faciales que, combinados hacen que cada persona pueda tener una imágen única y atractiva.

Aquí es donde la cirugía estética cumple su rol, conjugando ésto con arte y disciplina médica.

DETRAS DEL CAMBIO

La búsqueda de lo bello o el deseo del cambio están generados por factores íntimamente ligados con la edad. Es así como en **los menores de cinco años** son sus padres quienes desean eliminar en sus hijos marcas producidas por algún accidente, cicatrices dejadas por tratamientos médicos o malformaciones congénitas como labio leporino, lunares gigantes, manchas vasculares inestéticas (hemangiomas), etc.

A partir de los cinco años, con la socialización, es el propio niño quien busca el cambio, impulsado generalmente por las burlas de otros niños provocadas por algún defecto físico. A modo de ejemplo están los portadores de oreja en abano, malformación difícil de ocultar especialmente en los hombres. Motivados por su problema, los pequeños toleran las incomodidades propias de una cirugía con anestesia local.

En general, problemas estéticos como cicatrices visibles, no incomodan a los niños **hasta entrada la pubertad.** Es en esta etapa donde la imagen física cobra especial relevancia y pequeños defectos pasan a ser grandes problemas para el adolescente.

Especialmente en las jóvenes, se convierten en dificultades rasgos determinados genéticamente como el desarrollo inapropiado del busto o una distribución inadecuada de la grasa (muslos o caderas de volumen desproporcionado respecto al resto del cuerpo). Un dorso nasal con una giba inestética o pronunciada, también constituye una dificultad a esta edad.

Finalizada la adolescencia es el periodo en el que se suelen corregir quirúrgicamente cicatrices producto de accidentes o incluso de acné. Es en esta etapa donde la mujer da especial importancia al busto, fundamentalmente si hay un desarrollo exagerado.

A partir de los 30 años llegan los primeros signos del envejecimiento como la aparición de líneas de expresión o bolsas bajo los párpados inferiores e, incluso, superiores de los ojos. Estas también son causas de tratamiento quirúrgico.

La mujer que ha sufrido los cambios fisiológicos propios del embarazo, generalmente queda con un busto fláccido o, en ocasiones, atrofiado. Asimismo, el cuerpo puede perder el

contorno que poseía y aparecer flaccidez en el abdomen y cintura. Las estrías son otro de los factores que en esta etapa impulsan a la mujer a someterse a una cirugía estética.

Pasados los 40 años los inevitables signos que deja el tiempo en nuestro cuerpo se hacen más pronunciados. Es aquí donde comienza a perderse la línea continua del contorno del rostro y aparece algún grado de flaccidez en cara y cuello, además de la inestética papada.

Durante la menopausia continúa en la mujer la progresión de la flaccidez, producto de los cambios hormonales, la adiposidad se deposita en zonas no deseadas como caderas y cintura.

En los hombres, además de los mismos signos de envejecimiento de la mujer, aparece la pérdida progresiva del cabello.

Sobre los 60 años de edad, los signos de envejecimiento son la principal causa de consulta médica en el área estética.

En suma y como hemos señalado, junto con las distintas etapas del hombre y la mujer, hay diversos motivos que impulsan a acceder a una cirugía estética como son: recuperar la normalidad, corregir una desproporción de una zona del cuerpo en particular, el deseo de embellecer y el de rejuvenecer.

EL TRATAMIENTO

Cualquiera que sea el tratamiento quirúrgico a seguir, es recomendable que sea lo menos agresivo posible, cumpliendo las expectativas del paciente y con duración en el largo plazo.

Para demostrar lo anterior tomemos como ejemplo la mejoría nasal. Comencemos por indicar que ésta se puede lograr afinando los cartílagos de la punta de la nariz, mediante una cirugía ambulatoria y utilizando sólo anestesia local. Sin embargo, también hay casos en que el tratamiento indica una reducción del exceso óseo y cartilaginoso o del tamaño nasal, lo que hace recomendable la anestesia general.

ASPECTOS GENERALES DE LA CIRUGÍA

Independiente de la magnitud y del tipo de cirugía a realizar, las expectativas que el paciente tiene respecto a los resultados y de la forma en que será el postoperatorio (dolor, edema, reacción de familiares y amigos), implican algún grado de ansiedad. En estas situaciones el paciente puede solicitar algún relajante muscular o tranquilizante antes de realizar la intervención.

Conviene tener presente que la cirugía implica un movimiento, desplazamiento y manipulación de los tejidos lo que provocará una restitución fisiológica de estos en las semanas siguientes, y que presentará entre otros signos, edema (hinchazón), equimosis (cardenal), sensación de tirantez en la zona de cicatrización y grados variables de dolor.

POSIBLES COMPLICACIONES

En todo tipo de cirugía existe la posibilidad que se desarrollen complicaciones las que pueden ser inmediatas o tardías. Afortunadamente, la mayoría se puede tratar con medicamentos o pequeños procedimientos.

Inmediatas: Un control médico preoperatorio riguroso disminuye su frecuencia, sin embargo, en algunos casos puede presentarse sangrado mayor de lo habitual. Hay situaciones que ameritan el reponer sangre (en algunos hematomas) o revisar la coagulación del paciente.

Las técnicas quirúrgicas y anestésicas actuales garantizan un postoperatorio óptimo, aunque, en ocasiones se pueden producir (en cirugías de larga duración) coágulos en venas de las piernas (trombosis), o incluso complicaciones pulmonares. Si esto ocurriese se tomarán las medidas necesarias para lograr una solución del transtorno.

En cirugías prolongadas puede realizarse al día siguiente de la operación, un ecodoppler venoso de las piernas, para diagnosticar y tratar a tiempo la presencia de algún coágulo o trombo. Para prevenir este tipo de complicaciones, utilizamos tecnología específica con métodos de compresión y descompresión de extremidades inferiores así como, la utilización de heparina profiláctica en los pacientes de más riesgo. Información más específica puede consultarla al equipo médico.

Tardías: Son las dificultades que podrían presentarse varios días después de la cirugía. Habitualmente tienen solución pero requieren de más tiempo para su corrección definitiva.

Es así como en los siguientes días es factible una anemia producto de un sangrado importante o hematoma.

A pesar de que raramente se presenta, conviene saber que la necrosis de piel es una complicación posible tras un lifting, abdominoplastía o levantamiento mamario; el riesgo aumenta para pacientes fumadores (sobre 10 cigarros diarios), de ahí la conveniencia de dejar de fumar en lo posible un mes antes en estas cirugías.

El proceso de cicatrización también puede conllevar complicaciones. En algunos pacientes se ha observado a partir del segundo mes postcirugía, una distorsión en la cicatriz la que puede engrosarse y hacerse más notoria (queloide). Tratada adecuadamente el paciente sufre la incomodidad de esperar más de un año para que ésta mejore su aspecto.

Siguiendo con las cicatrices, cabe señalar que algunas se pigmentan tornándose oscuras. Se requiere paciencia y tiempo para que las cremas blanqueadoras resuelvan el problema.

Otra complicación tardía es la infección de la zona operada, aún cuando la incidencia en clínicas especializadas en cirugía estética es muy baja, debido a que habitualmente no hay pacientes hospitalizados con enfermedades infecciosas.

Con la finalidad de que el paciente tenga absoluta claridad de las etapas que se dan después de la cirugía, pasamos a dar una descripción detallada de lo que generalmente acontece en cada una de ellas:

PRIMER DIA POSTOPERATORIO: *Tranquilidad y descanso*

En general, el primer día después de la intervención, el paciente debe tener tranquilidad y descanso. Los dolores y las molestias son en general menores de lo esperado, si bien hay algunas incomodidades como mantener suero conectado a una vena, vendajes, y no poder dormir en la posición acostumbrada.

En la mayoría de los tratamientos, a excepción de rinoplastía, lifting y tratamientos del cuello, la alimentación es prácticamente normal. En estas tres cirugías mencionadas la masticación debe ser mínima durante casi una semana.

Para evitar trombosis venosa no se recomienda inmovilización en la cama por lo que el paciente, debe levantarse con ayuda y caminar por la habitación. Sin embargo, hay que evitar

levantarse bruscamente por la posibilidad de algún mareo (lipotimia) y evitar el exceso de movimientos en la zona operada, que pueden provocar dolor y/o sangrado.

Respecto al aseo, está permitido lavar todo el cuerpo excepto el área tratada, considerando que el rostro y cuero cabelludo tienen excelente recuperación. Se indica lavado de cabello día por medio con shampoo y acondicionador neutro, aún tratándose de lifting o cirugía de párpados.

Durante el primer día postoperatorio se realiza también la primera curación de la zona intervenida y los controles generales. Habitualmente en este día el paciente debe realizar un examen Vascular llamado Ecodopler Venoso y recibe el alta hospitalaria.

2do a 4to DIA POSTOPERATORIO: *Reposo moderado*

Por norma general y una vez en casa, el paciente debe seguir las indicaciones dadas para el primer día después de la intervención. Se exceptúan del reposo pequeñas cirugías con anestesia local.

Recomiendo un descanso relativo, deambulando dentro de la casa y manteniendo una temperatura ambiental moderada evitando calor excesivo, por tanto no se debiera utilizar mantas o frazadas eléctricas ni cubre colchones eléctricos durante un mes porque producen edema (inflamación) de la zona operada, vasodilatación y mayor enrojecimiento de las cicatrices. Si desea salir al jardín o la terraza puede hacerlo siempre y cuando no se exponga al sol directo.

En cuanto a la medicación, es habitual que recetemos algún antibiótico profiláctico, analgésico y antinflamatorio además de algún medicamento que proteja la mucosa gástrica. Aquellas personas que han presentado anteriormente gastritis es recomendable que ingieran los medicamentos durante las comidas.

La alimentación está prácticamente basada en la ingesta de alimentos ligeros, fibras y proteínas.

ENTRE EL 5to y 7mo DIA POSTOPERATORIO: *Primer control*

En esta etapa el paciente sale por primera vez de su casa para asistir a la evaluación postoperatoria en la clínica. Allí se realiza un control exhaustivo y curación de la zona operada.

En algunas cirugías como la de párpados se retira la mayoría de los puntos, ya que esta zona cicatriza rápidamente.

Al completar ya casi una semana de realizado el tratamiento los pacientes operados de procedimientos ambulatorios pueden conducir.

Habitualmente la ingesta de antibióticos se termina al séptimo día, excepto en los casos en que se mantenga algún tipo de drenaje.

En el caso de las abdominoplastías y en las cirugías mamarias no se puede mojar la zona tratada (mientras se mantiene el drenaje). El resto de los casos sí lo pueden hacer.

2da SEMANA POSTOPERATORIA: *Volviendo a lo habitual*

En este periodo se comienza una vida relativamente normal. La alimententacion es la acostumbrada, se ducha sin problemas, puede conducir e integrarse al campo laboral. Exceptuando los pacientes operados de lifting.

En este lapso se realizan nuevos controles en la clínica, con el fin de evaluar que el desarrollo del tratamiento sea el correcto. Se retiran casi la totalidad de los puntos dependiendo de la cirugía realizada. La exposición al sol continúa estando prohibida para todos los pacientes.

3era y 4ta SEMANA POSTOPERATORIA: *Sin sol, gimnasia ni alcohol*

En este periodo el paciente ya realiza una actividad prácticamente normal, aunque sin excesos. Por ejemplo el sol, calor, gimnasia y alcohol, están prohibidos.

Si bien se retiraron los puntos es normal la permanencia de edema (inflamación) en la zona operada como, también, grados variables de equimosis (hematoma) y de insensibilidad al tacto.

Tal como hay quienes desarrollan cierta insensibilidad en el área afectada, otros crean una hipersensibilidad al tacto que se manifiesta en una sensación de quemadura suave constituyéndose una molestia incluso el roce de la ropa. Esto suele desaparecer espontáneamente después de algunas semanas o con la indicación de algún analgésico común (no automedicarse).

Entre la tercera y cuarta semana después de la operación, las cicatrices son de color rosado y es normal sentir sensación de tensión o tirantez.

TRANSCURRIDO MAS DE UN MES DESDE LA OPERACION: *Evolución óptima*

A partir del día 31, se comienza a disfrutar plenamente del resultado de la cirugía. Si bien ya se puede hacer ejercicio, tomar sol y beber alcohol, se debe iniciar la nueva etapa en forma moderada, incrementándose progresivamente entre el 2do y 4to mes.

El edema o inflamación aún puede persistir (retención de líquido en la zona operada) el que usualmente aumenta y produce una sensación de tensión frente al ejercicio, calor o ingesta de alcohol.

Las cicatrices se observan algo enrojecidas y deben protegerse del sol con algún filtro solar, parches de silicona o con tela adhesiva de papel por tres meses, con el fin de mantenerla plana e inmovil evitando que la cicatriz se ensanche con el movimiento.

3er AL 12avo MES:

En general, las cicatrices van perdiendo su color rojizo y comienzan a tomar la misma pigmentación del resto de la piel. Se indicarán cremas específicas para blanquearlas.

La sensibilidad se ha recuperado en un grado importante y ya no hay reacciones locales ante el calor o la ingesta de alcohol.

A las pacientes operadas de implantes mamarios se les recomienda realizar hasta el año del postoperatorio, por lapso de un minuto y bajo el agua de la ducha, un masaje suave diario, evitando así una cicatrización que comprima el implante.

2do AÑO EN ADELANTE: *Preservando el resultado*

En este periodo ya culminaron todos los cuidados que implica la cirugía y comienzan todos aquellos para preservar el resultado.

En las cirugías faciales por ejemplo, se recomienda no abusar del sol, ni de los rayos ultravioleta por el envejecimiento que provoca.

Es importante también mantener la piel hidratada. Por norma general el resultado de las cirugías tendrán una duración mucho mayor en la medida que se eviten variaciones importantes en el peso, esto es sobre 4 kilos.

Es aconsejable realizar actividad física la que ayudará a mantener una buena figura, mejorando la tonicidad muscular y evitando la formación de tejido adiposo.

Se indica realizar un control cada 3 años de la zona tratada, con el fin de determinar a tiempo si es necesario efectuar mini procedimientos con anestesia local, para prolongar el efecto primario. Por ejemplo, cuando se trata de rejuvenecimiento del rostro se combate la aparición de arrugas rellenándolas con grasa extraída del propio paciente ó la administración de algún producto para disminuir la potencia muscular, etc.

LAS CIRUGIAS HABITUALES

IMPLANTE DE CABELLO

Existen múltiples técnicas de implantes de cabello. Algunas consisten en desplazar las zonas laterales del cuero cabelludo hacia la zona superior de la cabeza que es la que habitualmente pierde precozmente el cabello, principalmente en hombres.

Cada técnica quirúrgica tiene indicaciones precisas y también algunos riesgos y complicaciones.

A continuación nos referiremos a la técnica de Microimplante que presenta varias ventajas respecto a otras técnicas entre las cuales se encuentran el poder ser realizada con anestesia local, tener muy poco índice de complicaciones y tener un resultado sorprendentemente natural.

¿Cómo se realiza el implante? Se extraen folículos pilosos de la zona posterior de la cabeza. Estos folículos son preparados bajo microscopio para no dañarlos, el porcentaje de folículos que fallan es mínimo.

Se prepara la zona receptora con instrumental de microcirugía y se transplantan los folículos uno a uno para naturalidad del resultado. El cabello comenzará a crecer en forma progresiva.

• Preparación previa	Prohibida la ingesta de ácido acetil salicílico, vitamina E y anticoagulantes los 15 días previos al procedimiento.
• Duración procedimiento	Dos a seis horas según cantidad a implantar.
• Tipo de anestesia	Local - sedación.
• Internación	Usualmente es ambulatoria.
• Reposo estricto	Un día.
• Reposo moderado	Dos días.
• Retorno al trabajo	Segundo a quinto día.
• Sol	En 30 días.
• Resultados	En 90 a 180 días, puesto que se implanta sólo el folículo y el cabello debe crecer.
• Otros cuidados	Ducha desde el segundo día evitando mojar el cabello. Primer lavado de cabello entre el tercer y quinto día con shampoo PH neutro cuidando la zona del implante.
• Complicaciones	Hematoma en zona donante (menos del 0.5 %). Otras.

RELLENO DE ARRUGAS FACIALES Y/O LABIOS.

Las líneas de expresión y envejecimiento del rostro pueden ser suavizadas con productos de origen animal o sintetizados en laboratorio como también por células grasas obtenidas del mismo paciente.

La ventaja de lo primero es que vienen envasados, siendo su aplicación rápida y fácil. La desventaja es la posibilidad de reacciones adversas tanto en el corto como largo plazo. La silicona líquida se exceptúa, puesto que se ha comprobado que tiene efectos nocivos para la salud.

A continuación presentamos un cuadro comparativo de los dos sistemas de relleno de arrugas faciales y/o labios:

	Sintéticos (Acido hialurónico - Poliacrilamida, etc.)	Tejido adiposo propio
• Origen del material de relleno	Producto preparado en laboratorio.	Se extrae grasa del paciente.
• Preparación previa	Ninguna	Prohibida la ingesta de ácido acetil salicílico, vitamina E y anticoagulantes los 15 días previos al procedimiento.
• Duración procedimiento	15 a 20 minutos.	30 a 40 minutos.
• Tipo de anestesia	Ninguna o local.	Local.
• Internación	No tiene.	Ambulatorio.
• Reposo estricto	No es necesario.	No es necesario.
• Reposo moderado	Un día.	Uno a dos días.
• Retorno al trabajo	Mismo día.	Tres a cinco días.
• Sol	En dos días.	En 7 a 10 días.
• Resultados	Inmediato.	En 7 días ya que hay mayor edema (inflamación) en los primeros días.
• Complicaciones	A veces reacción fibrosa en la zona. Asimetrías. Otras.	Excepcionalmente infección, Equimosis (inflamación) o asimetrías. Otras.
• Duración estimada de resultados	6 a 12 meses.	Tres a cinco años.

Considerando los antecedentes expuestos, es indicado el tratamiento con productos sintéticos (todos de laboratorios internacionalmente conocidos) si el paciente necesita obtener un resultado inmediato por su trabajo o actividad social.

Por el contrario, si la persona desea un resultado duradero evitando todo tipo de rechazos a los productos, entonces se sugiere la lipoinyección.

Ahora bien, ambos procedimientos son aplicables en cualquier tipo de arruga facial, preferentemente, en aquellas líneas más profundas ubicadas a los lados de la nariz y boca, mejillas y cuello.

Las arrugas de la frente y contorno de ojos son el resultado de contracciones musculares repetidas. Las técnicas expuestas son efectivas en esta zona pero su duración es menor a las del resto del rostro.

En el caso de aumentar el espesor de los labios, es recomendable utilizar tejido adiposo que concede naturalidad al tacto y consistencia. Este tipo de tratamiento es el indicado para aquellas personas que desean embellecer esta parte de la cara o para devolver el espesor perdido... recordemos que uno de los signos de envejecimiento es la atrofia muscular de esta parte del rostro, la que se traduce en labios atónicos y delgados.

¿Qué complicación se puede registrar en el tratamiento a los labios? Existe la posibilidad de alguna asimetría por absorción irregular, la que se corrige en los siguientes 30 a 45 días con un pequeño procedimiento, algunos pacientes presentan equimosis (hematoma) y edema (inflamación) en la zona de lipoinyección, además de la región de extracción de tejido adiposo, los cuales se atenúan en pocos días hasta desaparecer.

CONTROL DE LA POTENCIA MUSCULAR

Hay personas que por características genéticas tienen algunos músculos faciales de un grosor y potencia mayor a lo habitual determinando la aparición de líneas de expresión más precoces y más profundas. Esto suele ocurrir en la frente, la glabela (zona entre ambas cejas) ó el contorno de los ojos.

Este exceso de potencia muscular se puede controlar de forma definitiva mediante una cirugía que puede ser directa o endoscópica, en la que los músculos involucrados son adelgazados parcialmente o en el caso del entrecejo incluso eliminarlos.

También es posible la aplicación de toxina botulínica tipo A en los músculos involucrados para conseguir efectos similares a los quirúrgicos, aunque por un corto período de tiempo (3 a 6 meses).

	Sintéticos (Toxina Botulínica)	Tratamiento quirúrgico
• Preparación previa	Ninguna.	Prohibida la ingesta de ácido acetil salicílico, vitamina E y anticoagulantes los 15 días previos al procedimiento.
• Tipo de anestesia	No requiere.	Local, sedación o general.
• Internación	No tiene.	Ambulatorio ó 1 día.
• Reposo estricto	No es necesario.	1 día.
• Reposo moderado	No requiere.	Dos a cinco días.
• Retorno al trabajo	Inmediatamente.	2 a 7 días.
• Resultados	A partir del quinto día.	Inmediatamente.
• Duración estimada de resultados	3 a 6 meses.	10 o más años.
• Alcohol y gimnasia	Gimnasia en 24 horas.	A partir de 10 días.
• Complicaciones	Asimetría Diplopía (visión doble 1%). Otras.	Hematoma (1%) Otras.

REJUVENECIMIENTO DE PARPADOS
BLEFAROPLASTIA

Si lo que se busca es recuperar el aspecto descansado y juvenil de los ojos, entonces lo indicado es la blefaroplastía que consiste en retirar el exceso de piel de los párpados superiores, inferiores o ambos. En quienes presentan un volumen exagerado de las bolsas adiposas que rodean el globo ocular chalasis de la piel por causas hereditarias, es indicado retirarlas.

En los párpados superiores quedará una fina línea cicatrizal en el centro del párpado y en el inferior la línea se ubicará debajo de las pestañas, rosadas en un comienzo lo habitual es que desaparezcan después de algunos meses. Para ayudar al proceso se utilizará una crema despigmentante. Pueden disimularse con maquillaje común a partir del décimo día si es necesario.

• Preparación previa	Prohibida la ingesta de ácido acetil salicílico, vitamina E y anticoagulantes los 15 días previos al procedimiento.
• Duración procedimiento	1 a 1 hora y media.
• Tipo de anestesia	Sedación, anestesia local o general, según deseo del paciente.
• Internación	Ambulatoria, aunque es recomendable una noche en la clínica.
• Reposo estricto	1 día.
• Reposo moderado	5 días.
• Retorno al trabajo	Entre el sexto y octavo día.
• Cuidados	Usar filtro solar por el lapso de un mes.
• Resultados	Se pueden apreciar luego del décimo día.
• Alcohol y Gimnasia	Después de 3 semanas.
• Retiro de los puntos	Entre el cuarto y sexto día.
• Maquillaje	A partir del décimo día.
• Coloración de cicatriz	Los primeros tres meses.
• Complicaciones	•Raramente se da equimosis (hematoma) de mayor duración a lo habitual (14 ó más días). •Ectropión (4 en 1000 casos y esto ha ocurrido principalmente por existir poca tensión en el músculo orbicular. Todos fueron corregidos satisfactoriamente). •Cicatrices enrojecidas o pigmentadas: por un periodo superior a los tres meses. Afortunadamente la incidencia de estos problemas es muy baja y solucionables. •Queratitis con lagrimeo espontáneo (complicación que debe ser tratada con medicamentos indicados por oftalmólogo). Otras.
• Duración estimada del tratamiento	8 a 10 años para la flaccidez de piel, 15 a 20 años para las bolsas.

ADELGAZAMIENTO DEL ROSTRO

Este procedimiento se puede realizar mediante dos técnicas: lipoaspiración y retiro de bolsas de bichat.

Lipoaspiración: En rostros redondeados es factible retirar tejido adiposo mediante la técnica lipoaspiración. Para esto se utiliza una cánula fina que se introduce por una mínima incisión realizada en el mentón o bajo el contorno del lóbulo de la oreja.

El resultado es estéticamente óptimo ya que los pómulos adquieren protagonismo y el rostro, en general, luce más atractivo. Algunos pacientes presentan equimosis (hematoma) y edema (inflamación) en la zona tratada los cuales se atenúan en pocos días hasta desaparecer.

Este procedimiento requiere de un vendaje sobre las mejillas durante 5 días, aproximadamente.

• Preparación previa	Prohibida la ingesta de ácido acetil salicílico, vitamina E y anticoagulantes los 15 días previos al procedimiento.
• Duración procedimiento	30 a 40 minutos.
• Tipo de anestesia	Local - local sedación.
• Internación	Ambulatoria.
• Reposo estricto	1 día.
• Reposo moderado	4 días.
• Retorno al trabajo	Entre el quinto y séptimo día.
• Sol	Después de tres semanas.
• Resultados	En 15 a 20 días.
• Alcohol y Gimnasia	Después de 3 semanas.
• Retirada de puntos	Entre el quinto y sexto día si existiera algún punto.
• Maquillaje	A partir del quinto día.
• Complicaciones	Hematoma (2 en 1000 casos). Otras.
• Irregularidades	Raramente se dan (3 en 1000 casos aprox.).

Técnica de retiro de bolsas de bichat: Todos tenemos en el espesor de las mejillas una bolsa adiposa que en algunas personas se encuentra hipertrofiada.

Su retirada parcial o total, según sea necesario, produce un adelgazamiento de las mejillas de aspecto muy natural realzando además los pómulos y la belleza del rostro. Es un procedimiento rápido que no requiere vendaje y que su resultado se aprecia alrededor de los 15 días, una vez que ha desaparecido el edema (inflamación) y equimosis (hematoma).

• Preparación previa	Prohibida la ingesta de ácido acetil salicílico, vitamina E y anticoagulantes los 15 días previos al procedimiento.
• Duración procedimiento	20 a 30 minutos.
• Tipo de anestesia	Local - local sedación.
• Internación	Ambulatoria.
• Reposo estricto	No requiere.
• Reposo moderado	3 días.
• Retorno al trabajo	Al día siguiente.
• Sol	En tres semanas.
• Resultados	Se aprecian a los 15 días.
• Alcohol y Gimnasia	Después de 3 semanas.
• Retirada de puntos	No hay.
• Maquillaje	A partir del mismo día.
• Otros cuidados	Enjuague bucal con antiséptico después de cada comida durante 7 días.
• Complicaciones	Hematoma (2 en 500 casos). Otras.

LIPOASPIRACION DE PAPADA

Esta técnica es recomendada para personas menores de 45 años dado que es importante que la elasticidad de la piel esté conservada para una buena retracción de ésta en los siguientes días al procedimiento.

Con la lipoaspiración se puede eliminar completamente la papada en personas jóvenes y parcialmente en quienes tienen más de 38 años. En caso de existir la posibilidad de pérdida de elasticidad de la piel de la zona, se opta por una extracción parcial del tejido adiposo. Algunos pacientes presentan equimosis (hematoma) y edema (inflamación) en la zona operada los cuales se atenúan en pocos días hasta desaparecer. Se indicaran cremas.

• Preparación previa	Prohibida la ingesta de ácido acetil salicílico, vitamina E y anticoagulantes los 15 días previos al procedimiento.
• Duración procedimiento	20 a 45 minutos.
• Tipo de anestesia	Local.
• Internación	Ambulatoria.
• Reposo estricto	1 día.
• Reposo moderado	5 días.
• Retorno al trabajo	Al séptimo día.
• Sol	Después de un mes de realizada la intervención.
• Resultados	15 a 20 días.
• Alcohol y Gimnasia	Después de 1 mes.
• Retirada de puntos	No hay.
• Maquillaje	A partir del retiro del vendaje.
• Otros cuidados	Mantener compresión en zona operada por 1 semana. No exponer al sol.
• Complicaciones	•Algunas irregularidades (1,5%) •Flaccidez de piel (1%), este porcentaje es bajo dado que no se debe realizar el procedimiento en personas con flaccidez previa. •Hematoma (1%). •Otras.

TRATAMIENTO DEL FOTOENVEJECIMIENTO

Es la corrección de pequeñas arrugas faciales y manchas del rostro, cuello, tórax y manos provocadas por una exposición solar acumulada durante años.

En un porcentaje importante de casos, estos problemas se corrigen con la técnica llamada peeling.

El peeling se efectúa mediante químicos, y/o dermoabrasión, técnicas que tienen como finalidad suavizar y eliminar pequeñas líneas de expresión o manchas faciales, dando como resultado una piel lozana y juvenil.

Hay que hacer la salvedad, sin embargo, que el peeling no involucra el retirar excesos de piel, ni corrección de flaccidez, salvo que se asocie a otro tratamiento quirúrgico.

Cualquier zona del rostro puede ser tratada mediante éstas técnicas.

Por químicos: El peeling se consigue con la aplicación de diversas sustancias cuya intención es producir una quemadura química en las capas superficiales de la piel.

Muchos de estos productos actúan suavemente como los ácidos glicólico, alfahidroxiacido y retinoico. Otros tienen una mayor efectividad pero requieren mayor tiempo para una recuperación de la piel, entre estos figuran el ácido tricloroacetico y el fenol pasando por muchas opciones intermedias.

La elección del tipo de peeling dependerá de la condición y del tipo de piel del paciente.

PEELING

• Preparación previa	No requiere.
• Duración procedimiento	15 a 30 minutos.
• Tipo de anestesia	Ninguna o local.
• Internación	Ambulatoria (1 día en peeling mas profundos).
• Reposo estricto	No requiere.
• Reposo moderado	Entre 1 a 5 días.
• Retorno al trabajo	Entre 1 a 10 días, dependiendo de la complejidad del tratamiento.
• Sol	Después de 2 a 3 meses de realizado el tratamiento.
• Resultados	Se perciben luego de 15 a 20 días.
• Alcohol y Gimnasia	21 días después del tratamiento.
• Retirada de puntos	No hay.
• Otros cuidados	Uso de filtro solar varios meses después del procedimiento. Uso de vaselina liquida varias veces al día por una semana.
• Complicaciones	•Blanqueamiento de la piel (2%). •Alteración de coloración de la piel (2%). •Toxicidad se puede dar en el caso de utilizar fenol. •Otras.

Dermo Abrasión: Es la eliminación de las capas superficiales de la piel mediante acciones mecánicas; esto es con ciertos tipos de esmeriles y papel lija.

Entre las ventajas de esta técnica podemos destacar:

-al no generar calor, no produce quemaduras en las capas profundas de la piel ni daña la dermis.

-cuando se requiere, se puede incrementar la profundidad de su acción de manera bastante precisa.

Entre las desventajas podemos mencionar:

-hay exudado sanguinolento que produce una costra importante, la que permanece durante 9 a 12 días.

DERMO ABRASION

• Preparación previa	No requiere.
• Duración procedimiento	20 a 60 minutos.
• Tipo de anestesia	Local o local sedación.
• Internación	Algunas horas o 1 día.
• Reposo estricto	1 día.
• Reposo moderado	10 días.
• Retorno al trabajo	De 10 a 14 días.
• Sol	En 2 a 3 meses.
• Resultados	Se perciben luego de 10 a 12 días de caída la costra.
• Alcohol	Después de 1 mes.
• Gimnasia	En 21 días.
• Retirada de puntos	No hay.
• Otros cuidados	•Uso de filtro solar. •No mojar y evitar humedad en zona tratada mientras mantenga la costra. •Evitar el calor
• Complicaciones	•Escasa en la literatura médica. •Potencialmente existen riesgos similares a otros peeling. •Otras.

RINOPLASTIA

Esta técnica está destinada a la corrección estética de la nariz en los casos que tenga una desproporción respecto de los rasgos faciales (giba nasal pronunciada, punta nasal caída o globosa) o simplemente que el paciente busque embellecerla.

Las alteraciones mencionadas, bastante habituales, como también otras menos frecuentes, son corregidas modificando la forma, tamaño y posición de los cartílagos y los huesos nasales.

Es conveniente realizar esta cirugía después de los 17 años de edad, una vez que la configuración facial es la definitiva. Sin embargo, hay excepciones como cuando la irregularidad de la nariz es muy pronunciada y afecta la estabilidad sicológica del paciente, entonces se efectúan procedimientos parciales quedando abierta la posibilidad de tener que realizar una nueva operación en el largo plazo.

Como paso previo a la rinoplastía es importante comprobar una adecuada anatomía interna nasal para evitar complicaciones en el postoperatorio como cambio de voz. Si en el examen se evidencian alteraciones del septo nasal (tabique) o cornetes, lo recomendable es realizar ambas correcciones en una misma intervención quirúrgica, la que entonces se denomina rinoseptoplastía.

• Preparación previos	•Prohibida la ingesta de ácido acetil salicílico, vitamina E y anticoagulantes los 15 días previos al procedimiento. •No fumar 2 semanas antes de la cirugía.
• Duración procedimiento	1 a 1 1/2 hora.
• Tipo de anestesia	General - local sedación.
• Internación	1 día.
• Reposo estricto	1 día.
• Reposo moderado	3 a 5 días.
• Retorno al trabajo	En 10 a 12 días.
• Sol	En 1 mes.
• Resultados	Los efectos se aprecian al retirar el yeso aunque persiste inflamación leve por 30 a 60 días.
• Alcohol	Después de 1 mes.
• Gimnasia	Transcurridas 3 a 4 semanas.
• Retirada de puntos	Los puntos internos se caen solos.
• Otros cuidados	•No mojar el yeso. •Al retirar el yeso al décimo día no se debe usar anteojos para evitar marcas o impresiones sobre la piel. •Utilizar filtro solar. Evitar el calor.
• Complicaciones	•Posibilidad de sangrado que requiera de taponamiento (1 en 1.000 casos). •Edema o hinchazón persistente sobre puntas nasales (3%), el cual cede con antinflamatorios o, en algunos casos, con la extracción de éste en un procedimiento con anestesia local. •Pequeñas alteraciones estéticas como leves asimetrías de callo óseo(0,5%) y se solucionan con procedimiento local. •Otras.

Una vez efectuada la operación por lo general, exceptuando pequeñas correcciones como cartílago y puntas nasales, es necesario dejar al paciente con taponamiento nasal por 24 horas o 4-5 días en el caso de corrección interna del tabique. Lo anterior dificulta un poco la respiración. Además, la nariz es cubierta por un pequeño yeso que se retira al décimo día.

OTOPLASTIA

Es la técnica para corregir la oreja en abano, malformación congénita que se caracteriza por carecer la oreja de las curvaturas y pliegues que hacen que adopte una posición más adherida al cráneo.

La otoplastía no deja cicatriz visible porque el tratamiento se efectúa mayoritariamente a través de una incisión realizada detrás de la oreja. Desde esta área se esculpe o talla el cartílago para que tome la forma estética deseada. El tratamiento se realiza por lo general en niños mayores de 6 años, siendo habitualmente definitivo ya que esta parte del cuerpo presenta, proporcionalmente, poco crecimiento.

• Preparación previa	•Prohibida la ingesta de ácido acetil salicílico, vitamina E y anticoagulantes los 15 días previos al procedimiento. •No fumar 2 semanas antes de la cirugía.
• Duración procedimiento	1 a 1 1/2 hora.
• Tipo de anestesia	Local o local sedación.
• Internación	Ambulatorio.
• Reposo estricto	1 día.
• Reposo moderado	4 a 5 días con vendaje sobre las orejas.
• Retorno al trabajo	Después de 2 semanas de realizada la intervención.
• Sol	Después de tres semanas de realizada la intervención.
• Resultados	Después de 1 mes.
• Alcohol y Gimnasia	Después de 1 mes.
• Retirada de puntos	En la primera semana se retira punto por medio. Durante la segunda todos los puntos.
• Otros cuidados	•Recomendaciones para dormir sin pasar a llevar la zona con puntos. •Lavado de cabello con shampoo y acondicionador PH neutro. •Uso de vendaje la primera semana. •Evitar el calor.
• Complicaciones	•Escasas en la literatura médica •Queloides (tiene tratamiento) •Hematoma (menos del 0.1%). •Otras.

LIFTING
Rejuvenecimiento facial

El lifting o ritidectomía es tal vez la más representativa de las cirugías estéticas, la que con las técnicas modernas ha dejado obsoleto el concepto de sólo "estirar la piel" con aspecto de cierta artificialidad.

Hoy en día se efectúa según las necesidades de cada paciente, a través de procedimientos idóneos que llevan a un resultado óptimo, natural y prolongado. En suma, es más que una operación específica es -podríamos decir- un grupo de cirugías con ciertos aspectos técnicos comunes que actúan sobre el tejido adiposo, muscular, aponeurótico y dérmico en áreas determinadas del rostro y cuello como es el lifting frontal, de cuello y de contorno de ojos. También están las ridectomías aplicables a casi toda la cara pero actuando con diferente intensidad, cuando junto al envejecimiento hay flaccidez de la piel, se retira el exceso por medio de incisiones en el cuero cabelludo y en el contorno de implantación de la oreja.

El Lifting o Rejuvenecimiento Facial se ha perfeccionado con innumerables detalles técnicos en el tratamiento de las estructuras del rostro de manera que además de la naturalidad del resultado, la evolución postoperatoria se desarrolla con un edema (inflamación) moderada a discreta, sin vendajes, con una dieta blanda y líquidos sin restricción evitando ingerir alcohol por 30 días por la vasodilatación que produce y que provocaría aumento del edema. Algunos pacientes presentan signos de equimosis (hematoma) y edema (inflamación) los cuales se atenúan paulatinamente de acuerdo a cada paciente.

• Preparación previa	Evitar fumar 30 días antes del procedimiento. Si tintura su cabello hacerlo entre el tercer y quinto día antes de la operación. Limpieza facial la tarde o noche anterior. Prohibida la ingesta de ácido acetil salicílico, vitamina E y anticoagulantes los 15 días previos al procedimiento.
• Duración procedimiento	3 a 5 horas dependiendo del tipo de lifting.
• Tipo de anestesia	General.
• Internación	1 día.
• Reposo estricto	1 día.
• Reposo moderado	5 a 12 días.
• Retorno al trabajo	En 10 a 14 días.
• Sol	Después de 2 a 3 meses. Recomiendo uso de anteojos para el sol y filtro solar factor 30 o más en el rostro durante este periodo.No exponer al sol directo las cicatrices en los tres primeros meses.
• Resultados	Los efectos se aprecian después de 15 días de realizado el tratamiento puesto que existe inflamación. Naturalidad después de 30 a 60 días.
• Alcohol y Gimnasia	Después de 1 mes.
• Retirada de puntos	Primera y segunda semana punto por medio, tercera semana todos los puntos.
• Insensibilidad en la zona del rostro	Durante 3 a 6 meses.

• Otros cuidados	•Lavado de pelo día por medio con shampoo y acondicionador PH neutro. •Tinturar el cabello después de 1 mes de realizado el procedimiento. •Se indicarán cremas para el edema (inflamación), equimosis (hematoma) y cicatrices. •Evitar el calor. •Si la cirugía contempla Rejuvenecimiento de Párpados, se indicarán lágrimas artificiales para el día y uso de ungüento oftalmico para la noche durante 10 días. •Maquillaje suave a partir del décimo día.
• Complicaciones	•Hematoma (2% de los casos) habitualmente aparece antes de 24 horas. •Necrosis parcial de piel (0,5%) aumenta en fumadores. •Cicatrices hipertróficas (0,5%) •Queloide, (0,5%) •Alopecia (caída del cabello) en cicatriz cuando ocurre es en alguna zona pequeña, incidencia 1%. •Otras.

AUMENTO DE MENTON

El Micrognatismo o Retrognatismo, nombres técnicos para la falta de volúmen o desarrollo inadecuado del mentón, pueden corregirse mediante diferentes técnicas quirúrgicas las que se aplican dependiendo de la magnitud del problema y de la decisión que tome el paciente respecto a una en particular, considerando las ventajas y desventajas de éstas.

Así se puede conseguir una mejor proyección del mentón a través de un simple implante de grasa en las zonas que lo requieren, usando materiales sintéticos para imperfecciones moderadas, o efectuando fracturas en la mandíbula con el fin de proyectar el tejido óseo.

El siguiente cuadro muestra las principales características de las técnicas que es posible aplicar para la corrección de éste problema:

	Lipoinyección	Implante sintético	Aumento óseo
• Preparación previa	Prohibida la ingesta de ácido acetil salicílico, vitamina E y anticoagulantes los 15 días previos al procedimiento.	Prohibida la ingesta de ácido acetil salicílico, vitamina E y anticoagulantes los 15 días previos al procedimiento.	Prohibida la ingesta de ácido acetil salicílico, vitamina E y anticoagulantes los 15 días previos al procedimiento.
• Tipo de anestesia	Local.	Local.	Sedación o general
• Duración procedimiento	30 minutos.	45 minutos.	1 a 2 horas.
• Internación	Ambulatorio.	Ambulatorio.	1 día.
• Reposo absoluto	No requiere.	No requiere.	1 día.
• Reposo moderado	1 día.	3 días.	7 días.
• Retorno al trabajo	1 día.	3 a 5 días.	7 a 10 días.
• Sol	Después de 15 días.	Después de 15 días.	Después de 15 días.
• Alcohol y Gimnasia	15 días después de operada.	Transcurridos 20 días.	En 1 mes.
• Presionar mentón	En 7 días.	En 1 mes.	En 1 mes.
• Otros cuidados	Evitar la exposición al sol y al calor.	Evitar el calor.	Evitar el calor.
• Complicaciones	Excepcionalmente.	•Infección1% de los casos. •Asimetría1% de los casos. •Otras.	•Infección 1% a 2%. •Asimetría 1% a 2%. •Otras.
• Duración estimada del resultado	5 años	De por vida	De por vida.

Todas las técnicas pueden disminuír en forma parcial la proyección obtenida en la cirugía por la absorción parcial de los tejidos grasos u óseos o por encaje parcial en los casos en que se ha usado implante, en todo caso habitualmente esta disminución a largo plazo es mínima, y si ocurre, es posible corregirla.

Ninguna de estas técnicas deja cicatriz visible dado que habitualmente el acceso se hace por dentro de la boca en la zona profunda del labio inferior.

AUMENTO DEL BUSTO

Condiciones genéticas pueden determinar que una mujer posea un busto pequeño en proporción al tórax o, en el caso del síndrome de polland, carecer absolutamente de la glándula mamaria situación en la que incluso puede faltar el músculo pectoral de un lado. En otros casos debido a la lactancia hay pacientes que sufren una disminución por atrofia de la glándula mamaria.

Para corregir las situaciones mencionadas la técnica habitual es la de aplicación de implantes mamarios. Todos estos implantes poseen una cubierta de silicona y se diferencian en el relleno, siendo los más comunes los de solución salina y de gel de silicona certificadas por la comunidad europea y FDA (USA).

Afortunadamente a pesar de multiples estudios científicos no se ha probado que los implantes produzcan cáncer como se dió a conocer en medios no científicos hace algunos años, e incluso su uso es una de las alternativas en la corrección y reconstrucción que se realiza en mujeres mastectomizadas (amputación mamaria) por haberse diagnosticado cáncer en la glándula mamaria, implantes que pueden ser colocados el mismo día de la mastectomía ó en un segundo tratamiento según las características individuales del caso.

Para conseguir el resultado deseado, se deben elegir implantes mamarios con una mezcla de características entre las que se cuentan:

• Preparación previa	Prohibida la ingesta de ácido acetil salicílico, vitamina E y anticoagulantes los 15 días previos al procedimiento. No fumar 3 semanas antes de la cirugía.
• Tipo de anestesia	General.
• Duración procedimiento	1 hora y media.
• Internación	1 día.
• Reposo absoluto	1 día.
• Reposo moderado	2 a 3 días.
• Retorno al trabajo	7 a 10 días.
• Sol y Gimnasia	1 mes después de la cirugía.
• Alcohol	Después de 1 mes.
• Retiro de puntos	Entre 15 a 21 días.
• Otros cuidados	•Uso de sostén deportivo día y noche durante 1 mes. •Ducha una vez retirado el vendaje. •Masajes diarios por 30 seg. en la ducha movilizando el implante, una vez indicado. •No conducir los primeros 10 días. •Uso de tela de papel o silicona en cicatriz durante los 3 primeros meses. •Evitar el calor.
• Complicaciones	•Hematoma en un 1% de los casos. •Encapsulamiento de la prótesis por una hipercicatrización interna, lo que se corrige a través de un procedimiento sencillo realizado con anestesia local (7%). •Cicatrices enrojecidas. •Queloides (tiene tratamiento). •Otras.

- **Tamaño:** lo habitual es desde 120 a 450 cc. Los más utilizados son los de alrededor de 220 cc.

- **Perfil:** para un mismo volumen existen varios perfiles como pueden ser bajo, moderado o alto, cada uno de ellos respecto a los otros, produce distintos resultados estéticos.

- **Forma:** Existen implantes cónicos, gota de agua, redondos, anatómicos, biodimensional, etc...

- **Textura:** de su cubierta: lisa o texturizada.

- **Ubicación:** pueden colocarse sobre o debajo del músculo pectoral. Se recomienda colocarlo sobre el músculo cuando hay cierta flaccidez o estrías en la piel mamaria, y bajo el pectoral cuando la piel es firme.

La elección del tipo de implante a usar la realiza el cirujano en base al deseo que manifiesta la paciente respecto a tamaño, forma y posición del busto.

REDUCCION DE BUSTO
MAMOPLASTIA REDUCTIVA

Características genéticas, estímulos hormonales relacionados o no con la lactancia, aumento de peso y otras causas pueden producir un aumento desproporcionado del tamaño del busto respecto del peso, estatura y contorno del tórax en algunas mujeres. Existen diversas técnicas quirúrgicas que solucionan el problema.

La cicatriz suele posicionarse alrededor de la areola, una vertical que va de la areola al pliegue mamario y en el pliegue mamario (dando la forma de T invertida). Las cuales se atenúan con el paso de los meses con la ayuda de cremas.

La lactancia se verá afectada en mayor o menor grado dependiendo de la reducción realizada.

• Preparación previa	Prohibida la ingesta de ácido acetil salicílico, vitamina E y anticoagulantes los 15 días previos al procedimiento. No fumar 3 semanas antes de la cirugía.
• Tipo de anestesia	General.
• Duración procedimiento	2 a 3 horas.
• Internación	1 día.
• Reposo absoluto	1 día.
• Reposo moderado	2 a 5 días.
• Retorno al trabajo	7 a 10 días.
• Sol y Gimnasia	Transcurrido 1 mes.
• Alcohol	Después de 1 mes.
• Retiro de puntos	Primera semana punto por medio de areola; segunda semana todos los puntos de areola; tercera semana todas las suturas intradérmicas. Generalmente los primeros 5 días se deja un drenaje el cual debe ser manipulado sólo por personal de la clínica. Su duración dependerá de la evolución de cada paciente.
• Otros cuidados	•Uso de sostén deportivo día y noche por un mes. •No conducir los primeros 10 días. •Uso de tela de papel o silicona en cicatriz durante los 3 primeros meses. •Ducha completa después de retirado el drenaje. •Evitar el calor.
• Complicaciones	•Hematoma en un 1% de los casos. •Necrosis areola 1% de los casos (tiene tratamiento). •Infección. •Cicatrices enrojecidas. •Queloides. •Otras.

LEVANTAMIENTO DE BUSTO

Es habitual que las mujeres, después del embarazo y lactancia o por cambios en el peso, sufran alteraciones estéticas en el busto.

El tratamiento destinado a levantar el busto, consiste en darle forma a la mama a partir del tejido existente, retirando la piel sobrante y corrigiendo la ubicación de la areola.

Como parte de la técnica quirúrgica se realiza fijación del tejido mamario al músculo pectoral para prolongar el resultado.

En pacientes en quienes esta técnica no se asocia a una reducción del tamaño no suele afectarse la lactancia.

La cicatriz suele posicionarse alrededor de la areola, una vertical que va de la areola al pliegue mamario y en el pliegue mamario (dando la forma de T invertida). Las cuales se atenúan con el paso de los meses con la ayuda de cremas.

• Preparación previa	Prohibida la ingesta de ácido acetil salicílico, vitamina E y anticoagulantes los 15 días previos al procedimiento. No fumar 3 semanas antes de la cirugía.
• Tipo de anestesia	General.
• Duración procedimiento	2 a 3 horas.
• Internación	1 día.
• Reposo absoluto	1 día.
• Reposo moderado	3 a 5 días.
• Retorno al trabajo	7 a 10 días luego de la operación.
• Sol y Gimnasia	Después de 1 mes.
• Alcohol	Después de 1 mes.
• Retiro de puntos	Primera semana punto por medio de areola; segunda semana todos los puntos de areola; tercera semana todas las suturas intradérmicas.
• Otros cuidados	•Uso de sostén deportivo día y noche por un mes. •No conducir los primeros 10 días. •Uso de tela de papel o silicona en cicatriz durante los 3 primeros meses. •Ducha una vez retirado el vendaje. •Evitar el calor.
• Complicaciones	•Hematoma en un 1% de los casos. •Cicatrices enrojecidas por mas tiempo de lo habitual. •Queloides. •Otras.

ABDOMINOPLASTIA

Variaciones en el peso, embarazos y otros factores, pueden causar flaccidez del abdomen. La abdominoplastía es la solución quirúrgica y consiste en retirar el exceso de piel y tejido adiposo.

La incisión se efectúa, generalmente, en la parte inferior del abdomen. Si es necesario se realiza una sutura de los músculos rectos anteriores del abdomen.

Cuando existen cicatrices en la mitad superior del abdomen, la cicatriz es vertical y en la línea media realizándose una abdominoplastia mixta.

En algunos casos se puede mejorar el resultado asociando una Lipoaspiración de la cintura o de la parte alta del abdomen, lo que puede realizarse simultáneamente o en el mes siguiente como un procedimiento ambulatorio con anestesia local.

• Preparación previa	Evitar fumar 3 semanas antes de la cirugía. Prohibida la ingesta de ácido acetil salicílico, vitamina E y anticoagulantes los 15 días previos al procedimiento.
• Tipo de anestesia	Peridural o general.
• Duración procedimiento	2 a 3 horas.
• Internación	1 día.
• Reposo absoluto	1 día.
• Reposo moderado	7 días.
• Retorno al trabajo	10 días.
• Sol y Gimnasia	Después de 1 mes.
• Alcohol	Después de 1 mes.
• Retiro de puntos y drenaje	Primera semana punto por medio del ombligo, segunda semana todos los puntos del ombligo, tercera semana todas las suturas intradérmicas. Generalmente los primeros 5 días se deja un drenaje el cual debe ser manipulado sólo por personal de la clínica, su duración dependerá de la evolución de cada paciente.
• Otros cuidados	•Uso de faja durante 1 mes día y noche. •Ducha completa después de retirado el drenaje. •No conducir los primeros 10 días. •Uso de tela de papel o silicona en cicatriz durante los 3 primeros meses. •Evitar el calor.
• Complicaciones	•Hematoma en un 1%. •Necrosis de piel 0,5%, aumenta en fumadores. •Cicatrices enrojecidas. •Queloides. •Infección. •Otras.

LIPOSUCCION

Esta es una técnica quirúrgica con la cual se extrae tejido adiposo con ayuda de una cánula.

En ocasiones este tejido adiposo se puede redistribuir en zonas que lo necesitan, como por ejemplo glúteos. Este procedimiento de reutilizar parte del tejido adiposo extraído se conoce como Lipoescultura.

Las pieles con flaccidez suelen plantear problemas en la estética del resultado por lo que existen limitaciones en cuanto a la indicación. La cicatriz es mínima.

Algunos pacientes presentan equimosis (hematoma) y edema (inflamación) en la zona tratada los cuales se atenúan paulatinamente de acuerdo a cada paciente, se indicará cremas

• Preparación previa	Prohibida la ingesta de ácido acetil salicílico, vitamina E y anticoagulantes los 15 días previos al procedimiento.
• Tipo de anestesia	Local, sedación, peridural ó general dependiendo de la extensión de la zona a tratar.
• Duración procedimiento	1 a 4 horas dependiendo de la extensión.
• Internación	1 día.
• Reposo absoluto	1 día.
• Reposo moderado	3 a 5 días.
• Retorno al trabajo	Después de 5 días.
• Sol y Gimnasia	Después de 1 mes.
• Alcohol	Después de 1 mes.
• Retiro de puntos	A partir del séptimo día.
• Otros cuidados	•Durante 1 mes se usarán panty, body o vendaje compresivo para una adecuada retracción de la piel. •Evitar el calor. •Se indicará drenaje linfático de ser necesario. •Ducha una vez retirado el vendaje. •No conducir la primera semana.
• Complicaciones	•Hematomas (muy ocasional) •Manchas en la piel. •Irregularidades en la zona tratada. •Infección. •Otras.

IMPLANTE GLUTEO

Cirugía que consiste en colocar un implante sintético (silicona) para atenuar una Ptosis (caida) del Glúteo, para aumentar su tamaño. Esta técnica se realiza a través de la zona interglútea, colocando el implante debajo del músculo glúteo mayor, y por encima del músculo glúteo menor, con lo que el implante es imperceptible al tacto y con una cicatriz poco notoria.

Los casos en que el aumento de volumen deseado es pequeño, no es necesaria esta técnica y se puede suplir con Lipoinyección, procedimiento menos complejo.

• Preparación previa	Prohibida la ingesta de ácido acetil salicílico, vitamina E y anticoagulantes los 15 días previos al procedimiento. No fumar 2 semanas antes de la cirugía.
• Tipo de anestesia	Epidural ó general.
• Duración procedimiento	$1^{1/2}$ a 2 horas.
• Internación	1 día.
• Reposo estricto	1 día.
• Reposo moderado	5 a 7 días.
• Retorno al trabajo	10 a 15 días.
• Sol y Gimnasia	Después de 1 mes.
• Alcohol	Después de 1 mes.
• Retiro de puntos	A la 3^{era} semana.
• Otros cuidados	•Dormir boca abajo o de lado las primeras 3 semanas. •Sentarse sobre muslos. •Realizar tocaciones con povidona yodada en la zona de incisión. •Evitar el calor.
• Complicaciones	•Hematomas en escaso porcentaje. •Infecciones (2%) •Contractura capsular •Otras.

IMPLANTE DE PANTORRILLA

Si la necesidad estética es aumentar el volumen de las pantorrillas, esto se logra con un implante de silicona que tiene forma de un grupo de fibras musculares, el que se implanta debajo de la aponeurosis del músculo gemelo interno, a través de una incisión, por detrás de la rodilla. La pantorrilla puede tener disminuído su volumen a consecuencia de un rasgo genético, como también por secuela de enfermedades como la poliomielitis que produce atrofia de la musculatura de la pierna y pantorrilla.

Estos implantes por lo general no engruesan los tobillos, si se desea aumentar el volúmen de ésta zona puede usarse injerto de grasa.

• Preparación previa	Prohibida la ingesta de ácido acetil salicílico, vitamina E y anticoagulantes los 15 días previos al procedimiento. No fumar 2 semanas antes de la cirugía.
• Tipo de anestesia	Epidural o general.
• Duración procedimiento	$1^{1/2}$ hora.
• Internación	1 día.
• Reposo estricto	1 día.
• Reposo moderado	2 a 4 días.
• Retorno al trabajo	7 días.
• Sol y Gimnasia	Después de 1 mes.
• Alcohol	Después de 1 mes.
• Retiro de puntos	10 a 15 días.
• Otros cuidados	•Utilizar zapatos con taco medio durante 10 días. •Uso de tela de papel o silicona en cicatriz durante los 3 primeros meses. •Evitar el calor.
• Complicaciones	•Hematomas en escaso porcentaje. •Infección. •Otras.

ASPECTOS A CONSIDERAR EN UNA CIRUGIA ESTETICA

Hay una serie de aspectos de los cuales el paciente debe conocer antes y después de la cirugía. Entre los más importantes están:

Alimentación:

Está ampliamente demostrado que la correcta nutrición está íntimamente ligada con la estética. Lo ideal es mantener una dieta equilibrada que brinde todos los requerimientos nutritivos para mantener las funciones orgánicas en un nivel óptimo que, finalmente, derive también en una piel sana.

Después de cualquier tipo de cirugía es recomendable seguir una dieta blanda, libre de substancias irritantes o condimentadas. Prefiera las verduras, jugos de frutas naturales, agua en abundancia y carnes blancas (pescados-aves).

Sol:

No hay duda que una piel bronceada es atractiva, pero no es siempre sinónimo de salud. Estudios científicos han demostrado que el abusar de los rayos solares es perjudicial para la piel, no sólo en lo que respecta a un envejecimiento prematuro sino también a situaciones tan extremas como producir un cáncer de piel.

Los rayos solares también afectan a las cicatrices o equimosis después una cirugía. Estos fijan el color prolongando el enrojecimiento durante meses. En el postoperatorio el sol produce calor, dilatando los vasos sanguíneos, produciendo, una mayor inflamación o edema del tejido.

Es recomendable, por norma general, el uso de bloqueador solar factor 30 o más en cicatrices y equimosis (hematoma); y no exponer al sol directo las cicatrices los primeros tres meses de postoperatorio.

Calor:

El calor producido por el sol o calefacción exagerada del ambiente produce vasodilatación que aumentará el edema (inflamación) de la zona operada, lo que conlleva a una recuperación del postoperatorio más lenta.

Es aconsejable no usar frazadas, mantas ó cubre colchones eléctricos durante el primer mes después del tratamiento. Hay que evitar las bolsas de agua caliente, baños calientes jacuzzi ó sauna.

Alcohol:

El alcohol al igual que el calor produce vasodilatación lo que puede retrasar la absorción del edema de la zona operada. En cirugías grandes se recomienda no consumir alcohol durante el primer mes después del tratamiento.

En cirugías pequeñas basta con evitar el alcohol por 2 semanas.

Ducha y Baño:

En muchas cirugías la ducha está permitida a partir del 2º día, puede mojar todo el cuerpo incluso la zona operada excepto si ésta aun con drenaje o vendaje. Debe ser rápida, con agua preferentemente tibia para que no haya riesgo de vasodilatación. En todo caso, cada paciente recibe instrucciones particulares sobre el tema.

El baño de tina y/o jacuzzi no está recomendado hasta pasado un mes de la cirugía para evitar una mayor vasodilatación, que influye en el edema o inflamación de la zona operada.

Piscina y Mar:

Si ya se le han retirado todas las suturas (puntos), por lo general no hay impedimentos para que practique natación. Es más, es especialmente recomendable en cirugías como la lipoaspiración para disminuír el edema o inflamación, en las que se puede practicar a partir del séptimo día de postoperatorio. Recuerde sin embargo practicarla en horas en que no se exponga al sol directo si presenta equimosis.

Ejercicio Físico:

Después de una intervención, el ejercicio físico debe ser gradual. Es aconsejable la movilización precoz para prevenir problemas vasculares. Con relación a ejercicio más intenso, ya sea gimnasia aeróbica, pesas, tenis, etc., lo indicado es efectuarlos después de un mes de la cirugía, con excepción de la natación que puede comenzar antes.

En general el ejercicio físico produce calor y vasodilatación, por lo tanto, mayor edema o inflamación.

Cicatrices:

Las cicatrices se producen tras una cirugía o traumatismo de la piel y, en la formación de ellas intervienen múltiples factores.

Es conveniente describir la apariencia de una cicatriz normal: en primer término debe ser lineal y lisa, al inicio de color rojizo, tonalidad que tiende a aclarar con el transcurso del tiempo (3 a 9 meses). A una cicatriz se le llama hipertrófica cuando se levanta y se hace gruesa, y se le llama queloide cuando éste aspecto se mantiene en el tiempo, habitualmente por más de un año.

Para que el proceso de cicatrización sea el correcto es recomendable el uso de filtro solar y uso de tela micropore en la cicatriz durante 3 meses, si ésta no está en el rostro. El rostro es una de las zonas con mejor cicatrización del cuerpo y no requiere por lo general el uso de tela de papel o silicona, basta con el uso de filtro solar y la crema despigmentante. Ahora bien, en ocasiones aún adoptando estas precauciones hay cicatrices que evolucionan como queloide (cordón), las que deben ser tratadas con medicamentos o procedimientos locales. Zonas de mala cicatrización son en general las piernas, pies y zona del esternón (centro del tórax anterior).

Medicamentos de Consumo Habitual:

Es importante, previo a una cirugía, que el cirujano y su equipo conozcan todos los medicamentos que habitualmente usted consume. Existen medicamentos que actúan sobre la coagulación de la sangre, por ejemplo: el ácido acetil salicílico, el que debe suspenderse al menos 15 días antes de la cirugía junto con la Vitamina E. Las hormonas y anticonceptivos, debieran si es posible evitarse desde 1mes antes de la cirugía para disminuír al mínimo el riesgo de formación de coágulos. Asimismo, el consumo de antidepresivos, anoréxicos y algunos antioxidantes, serán evaluados a fin de suspender o no su ingesta.

Cabe señalar que hay medicamentos que no se pueden suspender, tales como los utilizados por personas con problemas tiroideos, diabéticos o hipertensos. Es indispensable que el equipo médico sepa las medicinas que el paciente toma, esto evita cualquier riesgo en una cirugía electiva.

Vitaminas:

Múltiples son los beneficios de las vitaminas para el cuerpo. Se puede mencionar, por ejemplo, que actúan a nivel celular ayudando al organismo a normalizar los procesos fisiológicos alterados por agentes que dañan la dermis y la epidermis.

Con relación a la Vitamina E, que es en general muy beneficiosa, y de amplio consumo por sus propiedades antioxidantes; es necesario suspenderla 15 días antes de una cirugía y 15 días después, porque podría afectar la coagulación. La Vitamina C, en tanto, es recomendable para todas aquellas cirugías como lipoaspiración, porque favorece la síntesis de colágeno con lo que se espera una mejor adherencia de la piel al resto de los tejidos.

Anticoagulantes:

No deben tomarse antes de la cirugía, entre los de uso más habitual se cuenta el ácido acetil salicílico, ecotrín y vitamina E, porque aumentan el sangrado durante la cirugía y el riesgo de hematomas importantes en el postoperatorio. El ácido acetil salicílico es un compuesto que se encuentra con frecuencia en los medicamentos que tratan los síntomas de gripe.

Homeopatía:

Existen estudios que avalan que la ingestión de árnica, puesto que acelera la absorción de equimosis (sangrado bajo la piel).

En las cirugías del rostro y en lipoaspiraciones corporales, recomiendo tomarla 1 semana antes y despues de la cirugía.

Dosis: Arnica D6 (tabletas), 2 tabletas cada 8 horas.

Arnica D6 (glóbulos), 10 glóbulos cada 8 horas.

Hierbas Medicinales:

Recientes estudios científicos avalan la hipótesis que la coagulación puede ser afectada por algunos componentes presentes en las plantas. Entre éstas aparecen mencionadas el ginkgo biloba, el ginseng y el ajo como los más activos. Por lo que en general recomiendo abstenerse de ingerir este tipo de productos como mínimo 7 días antes, para disminuír el riesgo de afectación de la coagulación por mecanismos hoy en día no del todo conocidos.

Seguridad ante todo

Cuando una persona decide someterse a una cirugía plástica, debe tener conciencia de que es necesario cuidar algunos aspectos de seguridad pre y postoperatoria con el fin de conseguir un óptimo resultado.

Lo primero que se debe tener en cuenta antes de una cirugía es la evaluación anestésica, es por ello que en Clínica Héctor Valdés es obligatorio realizar este análisis unas semanas antes de la operación, el cual comprenderá exámenes físicos, exámenes de laboratorio, ingesta de medicamentos etc. De esta forma se determina que la condición de salud sea óptima para ser sometida a un procedimiento quirúrgico, no obstante a lo anterior usted como paciente deberá informar sus hábitos, tales como el cigarrillo, alcohol y medicamentos de uso habitual.

Otras de las medidas preventivas es el exámen ecodoppler venoso, que se realiza en todos los pacientes 24 horas después de producida su cirugía. Sin embargo cuando se trata de personas con antecedentes de varices o trombosis venosa, se debe efectuar el procedimiento de diagnóstico antes y después de la intervención a fin de resguardar la salud de quien se someta a una cirugía.

Reiterando que para mí y mi equipo su seguridad es lo más importante, entregamos este manual que ayudará a disipar sus dudas. No obstante a lo anterior, estamos día a día para atenderle y lograr que este proceso sea seguro y confiable.

INDICE

Unas palabras 05
Detrás del cambio 06
El Tratamiento 07

ASPECTOS GENERALES DE LA CIRUGIA

- Posibles complicaciones 09
- Primer día postoperatorio 10
- 2do al 4to día postoperatorio 11
- Entre el 5to y 7mo día postoperatorio
- 2da semana postoperatoria 12
- 3era y 4ta semana postoperatoria
- Transcurrido más de un mes desde la operación
- 5to al 12vo mes 13
- 2do año en adelante

CIRUGIAS HABITUALES

- Implante de cabello 15
- Relleno de arrugas faciales y/o labios 16
- Control de la potencia muscular 18
- Rejuvenecimiento de párpados 19
- Adelgazamiento del rostro 20
- Lipoaspiración de papada 22
- Tratamiento de fotoenvejecimiento 24
- Rinoplastía 28
- Otoplastía 29
- Lifting 31
- Aumento de mentón 33
- Aumento de busto 34
- Reducción de busto 36
- Levantamiento del busto 37
- Abdominoplastía 39
- Liposucción 40
- Implante glúteo 41
- Implante pantorrilla 42

ALGUNAS CONSIDERACIONES

- Alimentación 43
- Sol
- Calor 44
- Alcohol
- Ducha y Baño
- Piscina y Mar 45
- Ejercicio Físico
- Cicatrices
- Medicamentos de consumo habitual 46
- Vitaminas
- Anticoagulantes
- Homeopatía 47
- Hierbas Medicinales

© Copyright by Héctor Valdés
Inscripción Nº 121.138
Derechos exclusivos reservados
I.S.B.N. 956-291-068-7
Primera Edición agosto 2001
Segunda Edición marzo 2007
Prohibida todo tipo de reproducción total
o parcial de este libro sin permiso escrito
de Héctor Valdés
Camino Farellones 18.780
Lo Barnechea, Santiago de Chile.

SANTIAGO DE CHILE
Fonos: (56-2) 3216528 - 3216529
Fax: (56-2) 3216542
Casilla 130 Correo San Enrique
Lo Barnechea, Chile.
www.clinicahectorvaldes.cl
info@clinicahectorvaldes.cl